

医療処置を実施している患者の避難の方法

種類
対応

CV
PICC
末梢点滴

- ① 避難時に輸液の高さを維持したまま独歩可能な場合、そのままの状況で避難する。
- ② 避難時に輸液の高さを維持できず歩行できない場合、クレンメを止めて、患者に抱きこませる、又は患者と共にシートにくるむようにして避難する。避難場所まで来て再開する時は、再開できる状況であるか確認してから再開する。

輸液ポンプ
シリンジポンプ

ポンプが外せるかどうかは、患者の状況、投与している薬剤で判断する。

- ① ポンプが外せる場合は、ポンプを外す。
患者が独歩で避難できるときは、自然落下で調整する
患者が歩けない場合は、クレンメを止めて寝具などに巻き込んで避難する。
- ② ポンプが外せない場合は、避難開始ぎりぎりまでは、ポンプで落とし、移動の直前に、
クレンメを止めて、ポンプのコンセントを抜き、ポンプごと寝具にくるみ避難する。アラームはなるが、無視して避難所まで行く。再開する時は、再開できる状況であるかルートを確認し、閉塞アラーム解除の手順に従って(急速注入にならないように圧を抜いてから)開始する。

酸素
CPAP
ネーザルハイフロー

- ① 酸素ポンペを準備する。
- ② パルスオキシメーターを患者に装着する(患者に対して数が不足している場合は、患者の状況により優先順位を判断し、適宜測定する)。
- ③ 中央配管から酸素ポンペに、手順に従ってつなぎ代える。
- ④ 部署全体の酸素吸入患者を繋ぎ代えたら、部署のシャットオフバルブを閉鎖する。

人工呼吸器	最低でも 3 人を確保。可能であればそのうちの一人は医師。医師がどうしても確保できない時は、医師に人工呼吸器患者の避難準備を報告し、酸素量などの指示を仰ぐ。1人は酸素ボンベにつながったアンビューバックを押し、2人は移送に携わる。安全確保のために最後に避難する。人員が確保できない場合は、できるだけ安全と思われるところでアンビューバックを押しながら助けを待つ。 ① 酸素ボンベ、アンビューバックを準備する。 ② パルスオキシメーターを患者に装着する。 ③ 人工呼吸器を外し、酸素ボンベとつないだアンビューバックを装着、アンビューバックを押しながらエアーストレッチャーなどで移動する。
胸腔ドレーン	*移動時ドレーンのクランプは必要ない。 ① メラサキュームのコンセントを外す。 ② 独歩で避難ができる場合 メラサキュームをスタンドから外し持たせて避難させる。 ③ 歩けない場合 メラサキュームをスタンドから外し患者と共に避難する。
各種ドレーン マーゲンチューブ イレウスチューブ SB バック マルチチャネル PTCD チューブ等	*移動時クランプの必要ない。 ① 歩行可能な場合 排液ボトルまたは排液バッグを患者に持たせて避難させる。 ① 歩行できない場合 排液ボトル又は排液バックを患者と一緒にシーツなどでくるんで避難する。
直達牽引	① 下肢の場合 馬蹄型からロープを外す。 架台から静かに患肢を下ろし、馬蹄の下にタオルをあてて包帯又は絆創膏で患肢に固定する。 患者の身体をシーツで馬蹄ごと包む。 ② 上肢の場合 馬蹄型又は翼状ピンからロープを外す。 患肢を静かに下ろして体幹に包帯又は三角巾、絆創

	膏で固定する。
--	---------

2025 年4月